

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Fisioterapia reumatológica

Presente.

Lic. Cesar Borja Arenas



Reconocer el equipo multidisciplinario, valoración y conceptos generales de la fisioterapia reumatológica para el apoyo en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 01: Fisioterapia reumatológica

1. Rehabilitación y Reumatología
2. Reumatismo vs. Enfermedad reumatológica
3. Las enfermedades reumatológicas
4. Equipo multidisciplinario
5. Objetivos del equipo multidisciplinario
6. Objetivos de la Fisioterapia reumatológica
7. Valoración fisioterapéutica
8. Estrategias de tratamiento
9. Calidad de vida

Presente.

Ver el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=9ZiMpyzDvfw>

Aborda enfermedades que afectan a las articulaciones

Uno de los dolores comunes es el mecánico y el inflamatorio.

El dolor mecánico disminuye al descanso; y el inflamatorio aumenta al descansar la zona.

REHABILITACIÓN REUMATOLÓGICA

Ejemplos como la artrosis, artritis, osteoporosis, y otros.

Afecta el sistema osteomuscular y el sistema inmune.

El tratamiento ayudará a combatir el dolor y los síntomas asociados.

La Reumatología es la **especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas, autoinmunes y sistémicas**. Se trata de una de las especialidades que más avances en diagnóstico y tratamiento ha experimentado en los últimos años.

¿Qué se entiende por Reumatología?



¿Qué se entiende por Rehabilitación?

La rehabilitación es un **conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad** en individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno.



- **Reumatismo:** Hace referencia al **conjunto de dolencias** o molestias relacionadas con el aparato locomotor.
- **Enfermedad reumatológica:** Son aquellas patologías **generalizadas del tejido conectivo**, artritis, artrosis, enfermedades del raquis, enfermedades de las partes blandas (no articular), síndromes dolor regional y enfermedades óseas no traumáticas.

Las enfermedades reumatológicas **suelen ser de curso crónico, sistémicas y de naturaleza autoinmune**, que involucran principalmente articulaciones sinoviales y otros órganos como la piel y vísceras.

Pueden acompañarse de síntomas diversos como **rigidez matinal, fatiga, dolor, incapacidad funcional**, depresión y nódulos articulares.

Afectan a la persona emocional y funcionalmente, generando un complejo impacto en la salud y la **economía familiar** causando altos **costos** al sistema **de salud**.

El **tratamiento eficaz** de las enfermedades reumatológicas **requiere un cuidado** multiprofesional e interdisciplinario **integrado** y coordinado **que se centre en** las necesidades de la **persona**.



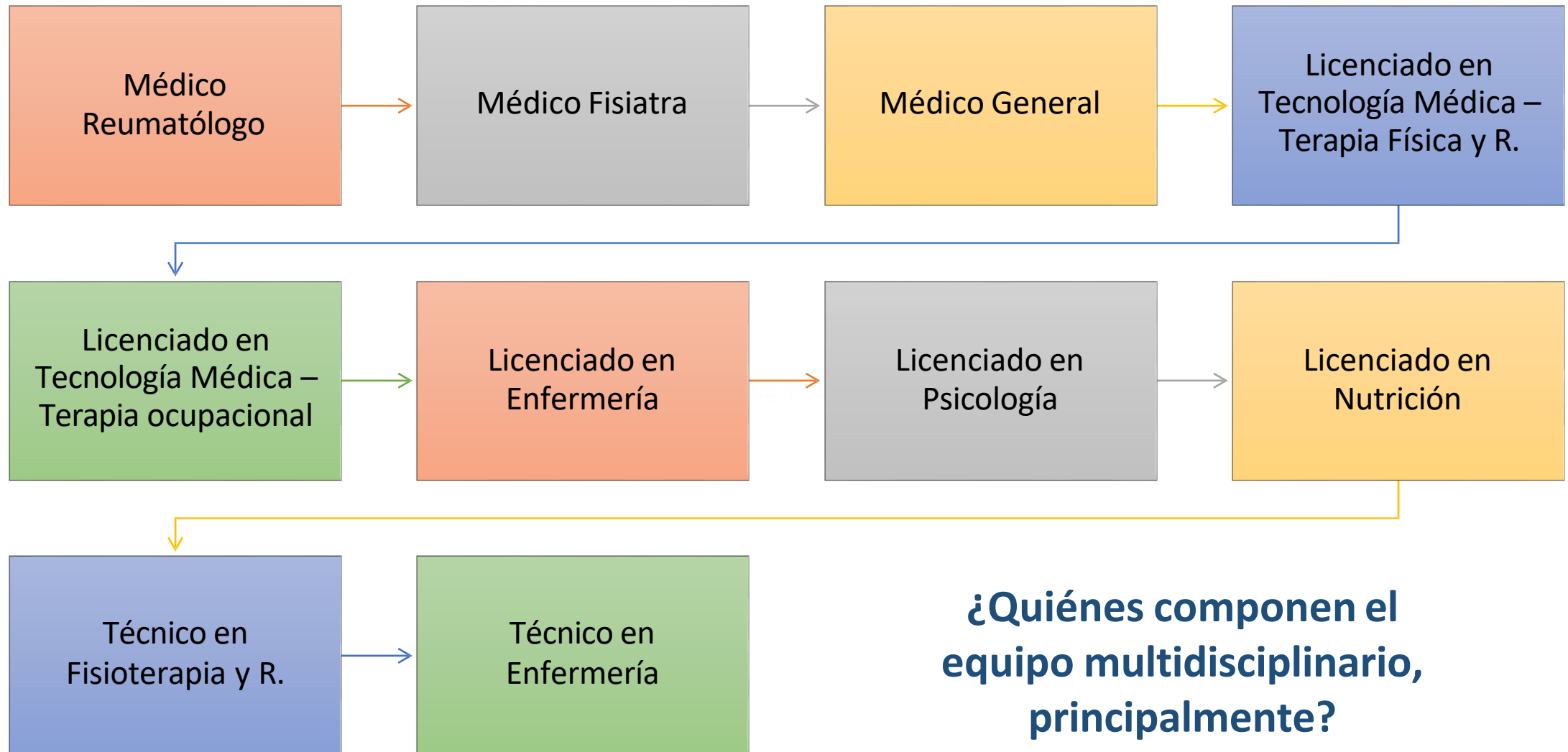
Estos servicios interdisciplinarios y multiprofesionales necesitan ser **coordinados e integrados** de tal manera que el **tratamiento** de dichas enfermedades sea **uniforme y sin interrupciones**.



Considerando la rehabilitación del paciente reumatológico, **el equipo multidisciplinario** **buscará cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y nutricionales** que devienen de las enfermedades reumatológicas.

Presente.





**¿Quiénes componen el
equipo multidisciplinario,
principalmente?**

El **Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación**, es un profesional independiente, altamente capacitado, con espíritu crítico, que actúa directamente con las personas, realizando la **evaluación, diagnóstico físico – funcional, programación y tratamiento para la promoción y prevención, mantenimiento y/o restablecimiento funcional en problemas de salud relacionados con deficiencias, discapacidades y minusvalías** buscando optimizar las capacidades fisiológicas y psico – neuro – sensorio motrices de la persona en relación con su entorno familiar, socio cultural y laboral; teniendo como objetivo de la reinserción físico – funcional. Interactúa con el equipo transdisciplinario de profesionales de salud para el logro de los objetivos de tratamiento.

El profesional **Técnico en Fisioterapia y Rehabilitación**, como parte del equipo multidisciplinario de salud, ofrece sus servicios en **apoyo al tecnólogo médico en el campo de la habilitación y la rehabilitación del movimiento corporal, a través del empleo supervisado de la electroterapia, mecanoterapia y masoterapia**. Para ello cumple acciones terapéuticas y preventivas en los diversos niveles de atención de salud y aplica normas y principios propios de la ética profesional.



**¿Qué objetivos
busca alcanzar un
equipo
multidisciplinario
en
rehabilitación?**

Acceso
oportuno para
la evaluación y
el diagnóstico.

Acceso
oportuno a un
tratamiento
preparado por
expertos para
las
enfermedades
reumáticas.

Seguimiento de
las
enfermedades
reumáticas por
expertos para
garantizar el
tratamiento
óptimo.

Formación,
asesoramiento
y apoyo para las
personas con
enfermedades
reumáticas para
permitirles que
traten sus
propias
enfermedades y
puedan tomar
decisiones
fundadas.

Colaboración
eficaz y
estrecha con
otras disciplinas
y profesiones
que participan
en el
tratamiento de
las personas
con
enfermedades
reumáticas.

¿Y qué busca la Fisioterapia Reumatológica?



El papel del licenciado tecnólogo médico con el apoyo del técnico en fisioterapia en estas enfermedades suele orientarse a la reducción del dolor, la prevención de la limitación articular y de la atrofia muscular, así como a la rehabilitación de la funcionalidad.

Alivio del dolor y control de la inflamación a través de la aplicación de medios físicos.

Mantenimiento o restauración de la función articular y muscular.

Mejorar la capacidad de marcha, equilibrio, coordinación y la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

Prevención de deformidades, rigideces articulares, déficits musculares y sensoriales.

¿Qué incluye la evaluación fisioterapéutica?



La anamnesis (entrevista) en la que se recopila información básica del paciente, antecedentes, proceso de la lesión o enfermedad y características del dolor o disfunción.



La observación inicial del balance corporal, emocional y social del paciente, uso de ayudas biomecánicas, postura global y patrón de marcha. Además, **la inspección** de las características superficiales de la zona a tratar sea a nivel de piel o respecto a alineación articular.



La palpación de estructuras presuntamente lesionadas o vulnerables del sistema musculoesquelético (músculo, tendón, ligamento, bursa, etc.).

¿Qué incluye la evaluación fisioterapéutica?



La **exploración** de los rangos de movimiento de las articulaciones comprometidas y la fuerza muscular que presenten. Asimismo, considera también el empleo de pruebas específicas según el cuadro a tratar.



La **valoración neurológica** considera la evaluación de la sensibilidad y la medición de los reflejos osteomusculares según el caso.



La **medición de la capacidad funcional** según la ejecución de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria del paciente. Además, considera la presencia de síntomas psicosociales (estrés, depresión, ansiedad, kinesiofobia, etc.) en el paciente.

Si el objetivo es
**disminuir el
dolor/inflamación;**
las estrategias a
considerar pueden
ser:

Termoterapia a través de CHC, IR,
parafina, etc.

Crioterapia por medio de compresas
frías, bolas de hielo, etc.

Electroterapia analgésica (TENS) a
intensidades según el caso

Ultrasonido terapéutico en
diferentes intensidades y frecuencias

Magnetoterapia y laserterapia según
protocolos preestablecidos

Si el objetivo es **mejorar los rangos de movimientos**; las estrategias a considerar pueden ser:

Estiramientos osteomusculares progresivos, sean asistidos o activos

Masoterapia considerando diversas técnicas según el objetivo que se busca

Movilizaciones activo-asistidas respetando el rango de dolor

La hidroterapia a través de tanques especiales o el uso de piscinas terapéuticas

Si el objetivo es
**mejorar la fuerza
muscular y
resistencia;** las
estrategias a
considerar pueden
ser:

Ejercicios de contracción isométrica

Ejercicios isotónicos libres o
anulando la acción de la gravedad

Ejercicios isotónicos resistidos con
bandas, pesas, mancuernas, etc.

Ejercicios aeróbicos controlados
(bicicleta estacionaria, caminadora,
baile, etc.)

Si el objetivo es **mejorar la funcionalidad e independencia** del paciente; las estrategias a considerar pueden ser:

Actividades funcionales para las praxias manuales

Plantear ejercicios que se relacionen a los gustos y actividades del paciente

Considerar el uso de ayudas biomecánicas para la ejecución de actividades

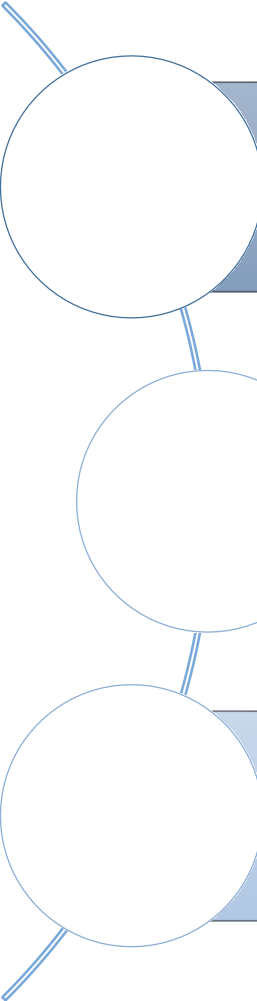
La calidad de vida es definida según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la **percepción individual de la vida dentro del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones.**



Incorpora diversos ámbitos, tales como el **físico (dolor, malestar, entre otros), psicológico (autoestima, imagen y apariencia personal), grado de independencia (movilidad, actividades de la vida diaria), relaciones sociales (actividad sexual), etc.**

Desde un enfoque global de la rehabilitación y en específico de la Fisioterapia reumatológica, se busca **generar cambios en el estilo de vida y abordar las disfunciones a consecuencia de las patologías reumatológicas.** Con ello, se pretende mejorar la calidad de vida del paciente en sus diferentes dimensiones.





1. PARA PODER ABORDAR ADECUADAMENTE AL PACIENTE REUMATOLÓGICO SE DEBE TRABAJAR EN CONJUNTO CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (REUMATÓLOGO, PSICÓLOGO, TECNÓLOGO, ETC.), LOS CUALES ESTARÁN ENFOCADOS A LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA.

2. LA REHABILITACIÓN REUMATOLÓGICA IMPLICA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEL TEJIDO MUSCULOESQUELÉTICO, CUADROS SISTÉMICOS Y AUTOINMUNES CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL DOLOR, LA RIGIDEZ Y OTROS SÍNTOMAS; LOGRANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA EL PACIENTE.

3. TAMBIÉN SE ABARCAN DOLENCIAS QUE AFECTAN MÚSCULOS, TENDONES, LIGAMENTOS, ETC. QUE PUEDEN ABORDARSE DESDE LA TERAPIA FÍSICA A TRAVÉS DE AGENTES FÍSICOS, MOVIMIENTO Y ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A MEJORAR LOS SÍNTOMAS DEL PACIENTE REUMATOLÓGICO.

- Olivé A, Monteagudo I, Wolf A. Sistema sanitario para los pacientes con enfermedades reumáticas: un servicio de reumatología. Seminarios de la Fundación Española de Reumatología. 2007; 8(3): 130-144. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-seminarios-fundacion-espanola-reumatologia-274-articulo-sistema-sanitario-pacientes-con-enfermedades-13109067>
- Hernández A, Puerto I, Falcón A, Morejón O, González D. Rehabilitación integral del paciente reumático. Revista Cubana de Reumatología. 2014; 16(1). Disponible en: <https://revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/rt/prINTERFriendly/296/Rehabilitaci%C3%B3n%20integral%20del%20paciente%20reum%C3%A1tico>
- Bellorin A, Zamara P, Bracho I, Valestrini E, Torres O, Noel G, Riera H. Calidad de vida en pacientes con artritis reumatoide. Avances en Biomedicina. 2018; 7(3): 150-162. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3313/331367295001/331367295001.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud. Rehabilitación. Ginebra: OMS; 2021. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/rehabilitacion#:~:text=La%20rehabilitaci%C3%B3n%20es%20un%20conjunto,%2C%20trastorno%2C%20lesi%C3%B3n%20o%20trauma.>

PREGUNTAS ACLARACIONES INTERVENCIONES



MUCHAS GRACIAS

Presente.